

# 간암 진단 첫 30일

## 간기능과 병기를 함께 보는 치료 흐름

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 10

완전판 · 2026년 10월 개정 2판

간암 치료는 ‘암’과 ‘남은 간의 힘’을 함께 봅니다.

## 이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Hepatocellular Carcinoma, Version 2.2026 외 국내 자료(본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

## 이 책의 사용법

이 책은 처음부터 끝까지 읽는 책이 아닙니다. **지금 내 상황에 필요한 장만 펴서 쓰는 책**입니다.

| 지금 내 상황              | 먼저 펼 곳                      |
|----------------------|-----------------------------|
| 방금 진단을 들었고 머리가 하얗다   | 1장 「먼저 구분하세요」 → 「진단 뒤 72시간」 |
| 몸에 이상 신호가 있다         | 「기다리지 않는 신호」 (응급 상자)        |
| 다음 주에 진료가 잡혀 있다      | 해당 치료 장 + 워크북 「진료 기록지」      |
| 검사 결과지를 받았다          | PART 1의 병리·검사·병기 장          |
| 돈·보험·회사가 걱정이다        | PART 5 「돈 · 서류 · 제도」        |
| 마음이 무너질 것 같다         | PART 4 「마음 돌보기」             |
| 가족으로서 무엇을 해야 할지 모르겠다 | PART 4 「보호자에게」              |

**각 장의 구성은 같습니다.**

- **30초 요약** — 바쁠 때는 이 상자만 읽어도 됩니다.
- **본문** — 왜 그런지, 무엇을 확인하는지.
- **오늘 물어볼 질문** — 진료실에 가져갈 질문은 장마다 3개 이내로 골랐습니다.
- **기록칸** — 들은 내용을 그 자리에서 적습니다. 보호자가 적어도 좋습니다.
- **🆘 응급 상자** — 기다리지 말고 연락해야 하는 신호입니다.

이 책의 표시:  확정된 정보 ·  검사·결정 대기 ·  아직 모름/확인 필요.  
색이 아니라 기호로 구분했으니 흑백으로 인쇄해도 그대로 쓸 수 있습니다.

# PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

## 1장. 먼저 구분하세요: 영상 진단, 간기능, 병기

### 30초 요약

- 간경변이나 B·C형 간염이 있는 고위험군에서는 **전형적인 영상 소견만으로 간암을 진단**할 수 있습니다. 조직검사가 늘 필요한 것은 아닙니다.
- 치료는 **종양(크기·개수·혈관 침범·전이) + 남은 간의 힘(간기능) + 전신상태**를 함께 보고 정합니다.
- 간암의 원인(B형간염·음주 등)을 누구 탓으로 돌리는 것은 치료에 도움이 되지 않습니다. **지금부터의 간 보호**가 중요합니다.
- **B형간염 항바이러스제는 끊지 않고 계속**(바이러스를 잘 억제하면 간암 치료 후 재발 위험이 줄어든다는 연구가 있습니다), **C형간염은 치료 전이라면 항바이러스 치료(대개 8~12주 먹는 약) 시기를 상의**하는 것이 간암 치료의 일부입니다.

## 판독지에 LR-숫자가 있다면(LI-RADS)

| 범주     | 뜻                              |
|--------|--------------------------------|
| LR-5   | 간세포암 확실 범주                     |
| LR-4   | 가능성 높음 — 추가 검사·조직검사·짧은 추적 논의   |
| LR-3   | 간세포암 가능성 중간 — 대개 짧은 간격으로 추적 영상 |
| LR-M   | 간세포암 외 악성 가능성 — 조직검사 고려        |
| LR-TIV | 혈관 안 종양(종양혈전)                  |

## 오늘 물어볼 질문

1. 제 간암은 영상으로 진단됐나요, 조직으로 확인됐나요?
2. 제 간기능(Child-Pugh·ALBI)은 어느 정도인가요?
3. 제 병기(BCLC·mUICC)는 무엇인가요?

## 2장. 기다리지 않는 신호

### ⚠ 응급 상자

- 갑자기 생긴 심한 배 통증 + 어지럼·쓰러질 것 같음(간암 파열 가능성) → 119 또는 즉시 응급실, 직접 운전 금지
- 피를 토하거나 검은 변(정맥류 출혈) → 119
- 낮밤이 바뀌고 멍함, 헛소리, 손 떨림(간성뇌증) — 보호자가 먼저 알아차리는 경우가 많음
- 배가 빠르게 불러오고 열·복통(복수 감염)
- 황달이 빠르게 진해짐
- 시술 후 고열이 지속되거나 다시 오름, 진통제로 조절되지 않는 통증
- 전신치료(면역치료·표적치료) 중 **38°C 이상 발열**, 숨참·기침, 하루 4회 이상 설사 → 해열제·지사제보다 먼저 치료팀에 연락
- 등 통증 + 다리 힘 빠짐·대소변 장애(척수 압박)
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ 109, 119

본문 목록:

1. 간암 파열은 내부 출혈로 생명이 위험할 수 있습니다.
2. 간경변 환자의 토혈·흑변은 정맥류 출혈일 수 있습니다.
3. 멍함·혼동은 마음 문제가 아니라 **간 문제(간성뇌증)**일 수 있어 락툴로오스 등 처방약을 임의로 끊지 말고 연락합니다.
4. 복수에 열이 나면 복막염 가능성이 있습니다.
5. 시술 후 열·통증이 수일 내 가라앉지 않으면 연락합니다.

6. 척추 전이에 의한 신경 압박은 시간이 중요합니다.

**간경변이 있다면 상의 없이 먹지 말 것:** 소염진통제(이부프로펜 등), 수면제·진정제, 임의의 한약·즙·건강기능식품. 진통제는 치료팀이 정한 종류·용량으로만. **변비**는 간성뇌증을 악화시킬 수 있어 관리합니다.

### 3장. 진단 뒤 72시간

**30초 요약:** 오늘은 ① 영상 판독지 받기 ② 간암 진료팀(소화기내과·간담췌외과·영상의학과) 예약 ③ 항바이러스제 복용 확인.

#### 오늘 할 일 (3개)

- ☐ CT·MRI 판독지(LR 범주)와 영상 CD
- ☐ 간암 다학제 진료 가능한 진료팀 예약
- ☐ B형간염 약(항바이러스제)을 먹고 있다면 **절대 임의로 끊지 않기**, 복용 여부를 기록

#### 이번 주 할 일

- ☐ 혈액검사(간기능, 간암 종양표지자 AFP·PIVKA-II, 혈소판), 흉부 CT, 필요 시 뼈스캔
- ☐ 위내시경(정맥류 확인 — 일부 전신치료 전 필수)
- ☐ 음주 중이라면 금주 지원 요청 — 끊기 어렵다는 것도 치료팀에 말해도 됩니다
- ☐ 가족 B형간염 검사·예방접종 상의
- ☐ 산정특례 신청(확진일로부터 30일 이내; **영상 진단 간암의 등록 기준**을 원무과에 확인)

#### 오늘 물어볼 질문

1. 추가 검사(조직검사·내시경)가 필요한가요?
2. 간염 치료는 어떻게 계속하나요?
3. 다학제 진료에서 치료를 상의하나요?

## 4장. 간기능과 병기

**30초 요약:** 간암 치료의 핵심 개념은 "얼마나 남은 간이 치료를 견딜 수 있는가"입니다.

| 평가                | 주요 요소                 | 환자가 이해할 점                 |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| Child-Pugh(A·B·C) | 빌리루빈·알부민·혈액응고·복수·간성뇌증 | A가 가장 좋음. B·C면 치료 선택이 좁아짐 |
| ALBI 등급           | 알부민·빌리루빈              | 간기능을 더 세밀하게 나눔            |
| 전신상태 (ECOG)       | 일상생활 정도               | 치료 강도 결정                  |
| 문맥압항진             | 정맥류·혈소판·비장 크기         | 수술 가능성에 영향                |

### 병기 이름이 두 개일 수 있습니다

- **BCLC(0·A·B·C·D):** 종양 + 간기능 + 전신상태로 단계를 나누며 **치료 방향과 연결**됩니다.
- **mUICC(I~IV):** 한국에서 많이 쓰는 종양 범위 중심 병기.
- mUICC는 ① 종양이 1개 ② 2cm 이하 ③ 혈관·담관 침범 없음, 세 조건 중 몇 개를 만족하는지로 I~III기를 나누고, 하나도 해당하지 않거나 림프절·다른 장기 전이가 있으면 IV기입니다.

| BCLC         | 쉬운 뜻                   | 흔한 치료 방향(국내 진료 차이 있음)                 |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|
| 0·A(초기)      | 작은 단일~소수 종양,<br>간기능 양호 | 절제·고주파/극초단파 소작·이식                     |
| B(중간기)       | 여러 개, 혈관 침범·전이<br>없음   | TACE(경동맥화학색전술) 중심, 일부 절제·<br>방사선·전신치료 |
| C(진행기)       | 혈관 침범 또는 전이            | 전신치료, 국내에서는 TACE + 방사선 병합도<br>흔함      |
| D(말기<br>간기능) | 간기능이 많이 나쁨             | 이식 평가 또는 증상 조절 중심                     |

## 조직을 얻었다면 보고서에서 볼 것

진단명(간세포암종 / 혼합형 / 기타), 분화도, 미세혈관 침범, 절제면, 배경 간  
(간경변 여부).

## 판독지 단어장

| 표현                         | 쉬운 말                  |
|----------------------------|-----------------------|
| arterial hyperenhancement  | 동맥기에 밝아짐 — 간세포암 특징    |
| washout                    | 이후 시기에 어두워짐 — 간세포암 특징 |
| portal vein tumor thrombus | 문맥 종양혈전               |
| ascites, varices           | 복수, 정맥류               |

내 기록: Child-Pugh \_ · **ALBI** \_ · BCLC \_ · **mUICC** \_ · AFP \_ · **PIVKA-II** \_ ·  
간염 ☐ B ☐ C ☐ 없음 · 항바이러스제 \_\_\_\_\_

# PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

## 5장. 치료 경로 지도

| 치료                     | 누구에게(예)                                             | 기억할 점                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 간절제                    | 간기능 양호, 남은 간이 충분                                    | 문맥압항진이 있으면 신중                                                 |
| 간이식                    | 기준 내 종양 + 간기능 저하                                    | 국내에는 <b>생체간이식</b> 비중이 큼                                       |
| 고주파·<br>극초단파<br>소작     | 작은 종양(대개 3cm 이하.<br>3~5cm는 TACE와 함께 하는<br>병합치료를 검토) | 짧은 입원                                                         |
| TACE(경동<br>맥화학색전<br>술) | 중간기                                                 | 반복 시행 가능                                                      |
| TARE(방사<br>선선택전술)      | 일부                                                  | 보통 두 번(사전 평가 → 치료). 국내는<br>2020년 말부터 건강보험 부분 급여 —<br>본인 부담 확인 |
| 방사선<br>(SBRT·<br>양성자)  | 소작이 어렵거나 혈관 침범                                      | 양성자는 일부 센터                                                    |
| 전신치료                   | 진행기, 국소치료 불응                                        | 아래 6장                                                         |

- 수술·소작 후 보조 면역치료:** 추적 결과 이득이 불확실해, 현재 **표준으로 확립된 보조 전신치료는 없다**고 보는 것이 일반적입니다. 임상시험으로 논의될 수 있습니다.
- TACE에 전신치료를 함께하는 전략이 연구되고 있으며 표준 여부·국내 허가·급여는 최신 근거 확인이 필요합니다.

- 시술 전 **혈액을 묽게 하는 약**을 먹고 있다면 알려세요. 국소치료 때도 **B형간염 재활성화**에 주의해 항바이러스제를 유지합니다.

## 6장. 전신치료

**30초 요약:** 1차 전신치료는 **면역 + 혈관신생억제 / 면역 + 면역 / 면역 단독 / 먹는 표적치료제(TKI)** 범주가 있습니다(국내 허가·급여 확인 필요). 간기능이 치료 선택을 좌우합니다.

| 범주             | 대표 예시                  | 기억할 점                       |
|----------------|------------------------|-----------------------------|
| 면역 +<br>혈관신생억제 | 아테졸리주맙 + 베바시주맙         | <b>시작 전 내시경으로 정맥류 확인·치료</b> |
| 면역 + 면역        | 더발루맙 + 트레멜리무맙 등        | 면역 관련 부작용                   |
| 면역 단독          | 더발루맙 등(국내 허가·급여 확인 필요) | 병용이 어려운 일부 환자               |
| 먹는 표적치료제       | 렌바티닙·소라페닙              | 고혈압·손발 피부·설사·피로             |
| 2차 이후          | 다른 TKI, 면역치료 등         | 1차에 따라 다름                   |

### 간기능이 많이 떨어져 있다면

- Child-Pugh **A**: 표준 전신치료 대상인 경우가 많음
- Child-Pugh **B**: 개별적으로 선택(근거 제한, 담당의 판단)
- Child-Pugh **C**: 항암보다 간기능·증상 관리, 이식 가능성 평가가 우선

## 진행·전이로 진단받았다면

### 30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

### 치료 목표를 묻는 질문

1. 이 치료의 목표는 무엇인가요? (암 크기 줄이기 / 진행 늦추기 / 증상 줄이기)
2. 치료 효과는 언제, 어떤 검사로 확인하나요?
3. 이 치료를 받지 않거나 쉬면 어떤 일이 예상되나요?

### 완화의료 이용하기

- 대부분의 암 병원에 **완화의료팀(자문형)**이 있습니다. 통증, 숨참, 메스꺼움, 불면, 불안 조절을 담당 교수에게 요청하면 연결됩니다.
- 호스피스·완화의료는 입원형·가정형·자문형으로 나뉘며, 지정 기관과 이용 조건은 국립암센터 중앙호스피스센터 누리집이나 병원 사회사업팀에서 확인합니다.
- 완화医료를 받는다고 해서 항암치료를 포기하는 것이 아닙니다.

### 미리 생각해 둘 것(원할 때만)

- **사전연명의료의향서**: 19세 이상이면 건강할 때도 작성할 수 있습니다. 보건소·지정 등록기관에서 작성하며, 언제든지 변경·철회할 수 있습니다 (국립연명의료관리기관).

- 치료를 잠시 쉬거나 멈추는 선택도 존중되는 결정입니다. 결정은 한 번에 하지 않아도 됩니다.
- 내가 직접 말하기 어려워질 때 나 대신 의견을 전할 사람을 정해 가족에게 알려 드립니다.

## 2차 소견과 병원 선택

### 30초 요약

- 2차 소견은 담당 의사를 의심하는 일이 아니라 **큰 결정을 확인하는 일**입니다. 대부분의 의사는 자연스럽게 받아들입니다.
- 2차 소견 때문에 치료를 몇 주씩 미루지 않도록 **일정을 먼저 정하고** 움직입니다.
- 가장 중요한 준비물은 병리 슬라이드·블록과 영상 CD입니다.

### 2차 소견이 특히 도움이 되는 경우

- 병리 결과가 드문 조직형이거나, 병원마다 해석이 갈릴 수 있다고 들었을 때
- 수술과 비수술 치료 중 선택지가 둘 이상일 때
- 기능 보존 수술이나 드문 치료처럼 경험 많은 센터가 중요한 치료일 때
- 설명을 들었는데도 결정이 서지 않을 때

### 병원을 고를 때 물어볼 것

1. 이 병원에서 간암 환자를 **다학제(여러 과가 함께 보는) 진료**로 상의하나요?
2. 제게 필요한 치료(수술·방사선·항암·임상시험 등)를 **한 병원**에서 받을 수 있나요?  
아니면 연계 병원이 정해져 있나요?
3. 치료 중 밤이나 휴일에 문제가 생기면 **어디로 연락**하나요?
4. 첫 치료까지 대략 몇 주가 걸리나요?

집과의 거리도 중요한 기준입니다. 매일 가야 하는 방사선치료나 잦은 외래가 예정되어 있다면, 통원 부담과 응급 시 이동 시간을 함께 따져 보세요.

## 2차 소견 준비 체크리스트

- ☐ 진료의뢰서(상급종합병원은 필수)
- ☐ 병리보고서 + 슬라이드/블록 대여
- ☐ 영상 CD + 판독지
- ☐ 혈액검사 결과, 복용 약 목록
- ☐ 내가 가장 궁금한 질문 3개(워크북 「질문지」)

## 최신 치료와 임상시험

- 임상시험은 "마지막에 기대는 실험"만이 아닙니다. 진단 초기부터 **표준치료와 함께 고려할 수 있는 선택지**입니다.
- 임상시험에 참여해도 언제든 그만둘 수 있고, 위약(가짜약)만 단독으로 쓰는 암 임상시험은 드뭅니다. 위약이 포함되면 사전에 설명을 듣습니다.
- 연구 약값은 보통 연구 쪽이 부담하지만, 교통비·추가 방문 등 부대 비용은 확인이 필요합니다.

### 찾는 곳

- 담당 교수에게 "제가 참여할 수 있는 임상시험이 있나요?"라고 직접 묻기 — 가장 빠릅니다.
- 한국임상시험포털(KoNECT), 식품의약품안전처 의약품안전나라 임상시험 정보, ClinicalTrials.gov(영문)

### 물어볼 질문

1. 이 연구는 무엇을 비교하나요? 표준치료를 받지 못하게 되나요?
2. 방문 횟수와 검사가 얼마나 늘어나나요?

3. 중간에 그만두면 어떤 치료를 받게 되나요?

---

## PART 3. 30일 실행 로드맵

### Day 0-3 · 확인하기

- ☐ 판독지·CD ☐ 간암 진료팀 ☐ 항바이러스제 유지 ☐ 간경변 약물 안전 확인  
☐ 연락처 저장

### Day 4-7 · 검사받기

- ☐ 간기능·종양표지자 ☐ 흉부 CT ☐ 위내시경(정맥류) ☐ 가족 간염 검사 상의  
☐ 산정특례

### Day 8-14 · 결정하기

- ☐ 간기능·병기 설명 ☐ 치료 방법 결정(다학제) ☐ 이식 가능성 ☐ 필요 시 2차  
소견

### Day 15-21 · 준비하기

- ☐ 시술·수술 전 검사 ☐ 항응고제 상의 ☐ 저염·고단백 식사 ☐ 금주 지원

### Day 22-30 · 시작하기

- ☐ 치료 시작 ☐ 시술 후 신호등 일지 ☐ 간성뇌증 관찰 카드(보호자)
-

# PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

## 시술 후 신호등

**30초 요약:** TACE·소작 뒤 수일간 미열·통증·메스꺼움(색전후증후군)은 흔합니다. 오래가거나 심해지면 연락하세요.

| 구분      | 증상                                               |
|---------|--------------------------------------------------|
| ● 괜찮은 것 | 수일 내 가라앉는 미열·오른쪽 윗배 통증·메스꺼움·피로                   |
| ▲ 전화할 것 | 퇴원 후에도 고열 지속·재발, 오한, 진통제로 조절 안 되는 통증, 황달, 소변량 감소 |
| ■ 응급실   | 갑작스러운 심한 복통과 어지럼, 토혈·흑변, 의식 변화                   |

- 간경변이 있어도 **단백질을 스스로 줄이지 마세요**(생선·달걀·두부, 늦은 저녁 간식). 복수가 있으면 저염이 특히 중요합니다.

## 간경변 환자 식사

- **저염**(복수가 있으면 특히), 충분한 단백질(생선·달걀·두부), 밤 간식(늦은 저녁 간식이 근육 유지에 도움).
- 날생선·날조개는 감염 위험이 있어 피합니다.
- 술은 끊습니다. 어렵다면 금주 지원을 요청하세요.

## 간성뇌증 관찰 카드(보호자용, 큰 글씨)

| 날짜 | 낮밤<br>바뀔 | 멍함·<br>헛소리 | 손<br>떨림 | 변<br>(횟<br>수) | 연<br>락 |
|----|----------|------------|---------|---------------|--------|
|----|----------|------------|---------|---------------|--------|

☐ ☐ ☐ ☐

> 하루 2~3회 부드러운 변을 목표로  
락툴로오스를 처방받는 경우가 많습니다. 임의로  
끊지 마세요.

## 시술 후 7일 일지

| 일 | 체온 | 통증 | 식사 | 메모 |
|---|----|----|----|----|
|---|----|----|----|----|

1~7

## 추적

- 치료 후 수개월 간격으로 영상(CT·MRI)과 종양표지자를 확인합니다. 간암은 남은 간에서 새로 생길 수 있어 **평생 정기 추적**이 중요합니다.
- 국내 자료로는 치료 뒤 첫 2년은 2~6개월, 그 뒤에도 3~6개월 간격으로 영상과 종양표지자 검사를 이어 갑니다. 절제 뒤 5년 안에 절반 안팎에서 재발하고 대부분 간 안에서 생기므로, 추적 일정을 거르지 않는 것이 중요합니다.
- 간염 치료와 간경변 관리를 계속합니다.

## 치료 중 흔한 증상, 집에서 할 일과 연락 기준

아래는 여러 암 치료에서 공통으로 흔한 증상입니다. **치료 병원의 안내가 항상 우선**이며, "연락" 칸에 해당하면 다음 예약까지 기다리지 마세요.

| 증상       | 집에서 할 수 있는 것                                                                 | 연락할 때                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 메스꺼움·구토  | 처방받은 구토 예방약을 <b>시간 맞춰</b> (증상이 생긴 뒤가 아니라 미리). 조금씩 자주, 차갑고 냄새가 약한 음식, 생강차·크래커 | 하루 3회 이상 구토, 물도 못 마심, 24시간 소변이 거의 없음         |
| 피로       | 짧은 낮잠(30분 이내), 가벼운 걷기, 우선순위 정해 에너지 아끼기, 도움 요청                                | 숨참·어지럼·심한 창백(빈혈 가능), 일상생활이 불가능               |
| 입안 혈음    | 부드러운 칫솔, 무알코올 가글(소금·베이킹소다 물), 자극적·뜨거운 음식 피하기                                 | 통증으로 먹거나 마시지 못함, 흰 반점·출혈, 발열 동반              |
| 변비       | 수분, 걷기, 처방 변비약. 진통제(마약성) 복용 중이면 변비약을 미리 함께                                   | 3일 이상 변이 없고 복통·구토, 배가 부풀                     |
| 설사       | 수분·전해질(이온음료 희석, 미음), 기름진 음식·유제품·카페인 줄이기, 처방 지사제                              | 하루 4~6회 이상, 밤에도 계속, 혈변, 어지럼·소변 감소, 면역치료 중 설사 |
| 불면       | 일정한 기상 시간, 낮잠 제한, 잠자리에서 휴대폰 멀리, 스테로이드는 아침 복용(지시대로)                           | 2주 이상 계속, 불안·우울 동반                           |
| 탈모       | 순한 샴푸, 짧은 머리, 모자·두건·가발, 두피 자외선 차단                                            | — (대개 치료 후 다시 자람)                            |
| 피부 발진·건조 | 순한 보습제 하루 2회 이상, 미지근한 물, 자외선 차단                                              | 물집·벗겨짐, 넓게 번짐, 점막(입·눈) 침범                    |
| 손발 저림    | 찬 것 피하기(일부 약), 따뜻한 양말·장갑, 낙상 주의                                              | 단추·젓가락·걸기가 어려워짐 — 다음 투여 전에 꼭 알리기             |

| 증상                    | 집에서 할 수 있는 것                      | 연락할 때                                |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 식욕<br>저하·<br>체중<br>감소 | 먹을 수 있을 때 먹기, 고단백 간식, 영양 보충<br>음료 | 한 달 5% 이상 체중 감소,<br>평소의 절반 이하로 1주 이상 |

**열이 나면:** 항암 중 38°C 이상(병원 기준에 따라 37.8°C 이상 1시간 지속 등)은 **해열제를 먹기 전에 먼저 연락**하는 것이 원칙입니다. 열을 내리면 감염 신호를 놓칠 수 있습니다.

## 마음 돌보기

### 30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 \_\_\_\_ 점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

### 내 마음 온도계(고통 선별)

지난 1주일 동안 내 마음의 고통은 몇 점이었나요? (0 = 전혀 없음, 10 = 극심함)

날짜    점수(0~10)    가장 힘든 것( ☐ 걱정 ☐ 잠 ☐ 통증 ☐ 돈 ☐ 가족 ☐ 일 ☐ 기타)

- **4점 이상**이 계속되면 다음 진료 때 점수를 그대로 말하세요. 대부분의 암 병원에는 정신건강의학과·임상심리·사회사업팀 연결 경로가 있습니다.
- 불면이 1~2주 이상 계속되면 수면 치료를 받을 수 있습니다. 잠은 치료를 건디는 체력입니다.
- 병원 밖 도움: 전국 지역암센터의 **암생존자통합지지센터**(☎ 1577-9740)에서 상담·심리지지·자기관리 프로그램을 운영합니다. 암 정보가 궁금하면 국가암지식정보센터 상담(☎ 1577-8899, 평일 9~18시)을 이용할 수 있습니다.

## 불안이 몰려올 때 5분 방법

1. **숨:** 4초 들이쉬고, 6초 내쉬기를 5번.
2. **이름 붙이기:** "지금 나는 ○○ 결과가 걱정된다"라고 소리 내거나 적기.
3. **내 몫 나누기:** 지금 내가 할 수 있는 일 1개(전화 1통, 서류 1장)와 의료진 몫을 나눠 적기.
4. **정보 시간 정하기:** 인터넷 검색은 하루 30분, 정해 둔 시간에만. 밤 검색은 불안을 키웁니다.

## "내 탓일까?"라는 생각

암은 한 가지 원인으로 생기지 않습니다. 생활습관, 감염, 유전, 나이, 그리고 설명되지 않는 우연이 겹칩니다. **원인 찾기보다 지금부터의 계획**에 에너지를 쓰는 편이 나를 돕습니다. 가족이나 주변 사람이 원인을 따져 묻는다면 "지금은 치료 계획에 집중하고 싶어"라고 말해도 됩니다.

## 희망과 현실을 함께 들고 가기

통계(생존율)는 많은 사람의 평균이지 나 한 사람의 예언이 아닙니다. 궁금하다면 담당 의사에게 "제 병기와 상태에서 치료 목표가 무엇인가요?"라고 물어보세요. 들고 싶지 않은 정보는 "지금은 듣지 않겠다"고 말할 권리도 있습니다.

# 보호자에게

## 보호자가 첫 30일에 할 수 있는 가장 좋은 일

- **기록 담당:** 진료실에서 답을 적습니다. 환자는 듣는 데 집중할 수 있습니다.
- **일정 담당:** 검사·진료·서류 일정을 한 곳(달력·앱)에 모읍니다.
- **연락 창구:** 친척·지인에게 소식을 전하는 사람을 한 명으로 정하면 환자가 같은 이야기를 반복하지 않아도 됩니다.
- **결정은 환자:** 의견은 말하되, 치료 결정의 주인은 환자입니다.

## 피하면 좋은 말과 바꿔 쓸 말

| 피하면 좋은 말          | 바꿔 쓸 말                           |
|-------------------|----------------------------------|
| "긍정적으로 생각해야 나아"   | "힘든 마음 그대로 말해도 돼"                |
| "왜 검진을 안 받았어"     | "지금부터 같이 챙기자"                    |
| "○○ 먹으면 낫는데"      | "새로 먹고 싶은 게 있으면 의사 선생님께 같이 물어보자" |
| "너보다 더 힘든 사람도 있어" | "네가 힘든 건 힘든 거야"                  |

## 아이에게 알릴 때

- 아이의 나이에 맞게, **짧고 사실대로:** "(엄마·아빠·할머니 등 아이가 부르는 호칭)가 몸에 아픈 혹이 생겨서 병원에서 치료를 받을 거야."
- 아이가 자주 하는 걱정 세 가지에 먼저 답합니다: **네 탓이 아니야 / 윗은 병이 아니야 / 누가 너를 돌봐줄지 정해져 있어.**
- 학교 담임에게 알릴지, 누가 알릴지 미리 정합니다.

## 보호자의 휴가 제도

일하는 보호자는 **가족돌봄휴직**(연간 최대 90일)과 그 안에서 하루 단위로 쓰는 **가족돌봄휴가**(연간 최대 10일)를 회사에 신청할 수 있습니다(남녀고용평등법,

2026.10 기준·고용노동부 확인). 진료 동행이 잦은 첫 30일에 특히 유용합니다.

## 보호자 자신을 위해

보호자의 소진은 흔합니다. 하루 30분은 나를 위한 시간을 지키세요. 병원  
사회사업팀과 환우·보호자 모임은 보호자도 이용할 수 있습니다.

## 직장과 일상

---

- **언제·누구에게·얼마나** 말할지는 내가 정합니다. 직속 상사와 인사 담당자에게 "치료 일정 때문에 근무 조정이 필요하다" 정도만 알려도 충분한 경우가 많습니다.
- 치료 일정이 나오면 **근무 조정안**(단축근무, 재택, 연차·병가 조합)을 내가 먼저 제안하면 협의가 쉬워집니다.
- 피로는 치료 중 가장 흔한 증상입니다. 치료 직후 며칠은 일을 줄이는 계획을 미리 세웁니다.
- 자영업자라면 매출보다 **현금 흐름 3개월**을 먼저 계산하고, 사회사업팀에 지원제도를 문의합니다.
- 복귀는 한 번에 100%가 아니라 단계적으로. 복귀 시점은 담당 의사와 상의합니다.
- 암생존자통합지지센터(☎ 1577-9740)에는 직장·학교 복귀를 돕는 프로그램이 있습니다(지역별 운영 확인).

## 먹는 것과 움직이는 것

---

### 식사 원칙

- 치료 중 목표는 "특별한 음식"이 아니라 **체중과 근육 유지**입니다. 고른 식사와 충분한 단백질(생선·달걀·두부·살코기·유제품)을 챙깁니다.

- 암 치료에 특별히 좋은 음식이나 꼭 피해야 할 "나쁜 음식"이 따로 정해져 있지는 않습니다. "좋다는 음식"만 먹거나 여러 음식을 가리면 오히려 영양이 치우치고 체력이 떨어져 치료를 버티기 어려워집니다.
- 입안이 험했을 때는 잡곡밥보다 부드러운 흰쌀밥이 나올 수 있고, 체중이 줄고 있다면 기름을 지나치게 제한할 필요도 없습니다. 유기농 식품이 치료에 특별히 도움이 된다는 근거는 뚜렷하지 않습니다.
- 체중이 한 달에 5% 이상 줄거나 먹는 양이 평소의 절반 이하로 1주 이상 이어지면 영양 상담을 요청합니다.
- 항암치료 중 면역이 떨어질 때는 날음식·덜 익힌 고기·살균 안 된 유제품을 피하라는 안내를 받을 수 있습니다. 병원 안내를 따르세요.
- **건강기능식품·한약·즙·고용량 비타민**은 항암제나 수술·방사선과 상호작용하거나 간·신장에 부담을 줄 수 있습니다. 시작 전에 꼭 의료진과 약사에게 보여 주세요.

## 움직이기

- 걷기처럼 가벼운 활동은 피로와 기분을 개선하는 근거가 있습니다. 컨디션에 맞춰 하루 10분부터 시작합니다.
- 일반적인 건강 목표는 주 150분 중간 강도 활동이지만, 치료 중에는 **할 수 있는 만큼**이 기준입니다.
- 발열, 심한 빈혈·어지럼, 뼈 전이 통증, 수술 직후에는 운동 강도를 의료진과 상의합니다.
- 담배는 상처 회복과 치료 효과, 다른 암 위험에 모두 영향을 줍니다. 금연 클리닉(보건소)과 금연상담전화 ☎ 1544-9030을 이용하세요.

# PART 5. 돈 · 서류 · 제도

## 한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

### 30초 요약

- 1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
- 2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
- 3. **제도는 바뀔니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

### 1. 산정특례(중증질환 본인부담 경감)

| 항목       | 내용(2026.10 기준, 확인 필요)                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 대상       | 암으로 확진된 환자(간암 포함). 상피내암(0기)·경계성 종양 등은 대상·비율이 다를 수 있어 원무과 확인     |
| 혜택       | 건강보험 <b>급여</b> 진료비의 본인부담 약 5%(입원·외래). 비급여·선별급여는 해당하지 않거나 비율이 다름 |
| 기간       | 적용 시작일(확진일 또는 신청일)부터 5년. 5년 뒤 남아 있는 암·재발·전이가 있으면 재등록 심사         |
| 신청<br>시한 | <b>확진일로부터 30일 이내</b> 신청하면 확진일부터 적용. 그 뒤에 신청하면 신청일부터 적용          |
| 방법       | 진단한 의사가 산정특례 등록 신청서를 작성 → 대부분 병원 원무과가 공단에 전송. 직접 제출도 가능         |

## 확인할 것

- ☐ 병원이 대신 접수했는지, 등록 결과(문자·공단 앱)를 받았는지
- ☐ 다른 병원으로 옮겨도 산정특례는 유지됩니다. 새 병원 원무과에 등록 사실만 알리면 됩니다.
- ☐ 확진 전 검사비는 적용 시점에 따라 경감되지 않을 수 있습니다.

## 2. 의료비 부담을 덜어주는 제도

| 제도                 | 핵심                                                   | 문의                 |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| 본인부담상한제            | 1년간 낸 건강보험 본인부담금이 소득 구간별 상한을 넘으면 남은 금액을 돌려받음(비급여 제외) | 국민건강보험공단 1577-1000 |
| 재난적 의료비 지원         | 소득·재산 기준을 충족하고 의료비 부담이 큰 경우 일부 지원(비급여 일부 포함)         | 공단 지사·병원 사회사업팀     |
| 국가 암환자 의료비 지원      | 의료급여 수급자·차상위 등 해당자 대상 지원                             | 주소지 보건소            |
| 병원 사회사업팀 (의료사회복지사) | 후원 연계, 간병·교통·숙소 정보, 제도 신청 도움                         | 진료 병원 사회사업팀        |

대상 기준과 금액은 해마다 바뀝니다. "내가 해당되는지"는 병원 사회사업팀에 한 번에 물어보는 것이 가장 빠릅니다.

## 3. 보험 청구 서류 체크리스트

### 민간 암보험(진단비)

- ☐ 진단서(질병분류코드 포함) — 보험사 양식이 있는지 먼저 확인
- ☐ 조직병리검사 결과지(병리보고서) — 대부분의 약관이 병리 확정을 요구합니다

- □ 약관에서 "**유사암·소액암**"(갑상선암, 제자리암/상피내암, 경계성 종양, 기타 피부암 등) 분류를 확인 — 진단비가 다를 수 있습니다
- □ 청구 기한(보험금 청구권 소멸시효는 3년)

### 실손의료보험

- □ 진료비 영수증 + 진료비 세부산정내역서(비급여 항목 확인용)
- □ 일정 금액 이상은 진단서·입퇴원확인서 추가
- □ 가입 시기에 따라 보장 범위(비급여 주사·도수 등)가 다릅니다

보험 상담에서 "진단서는 몇 통이 필요한가요?"를 먼저 물어보고, 병원에서는 한 번에 필요한 부수만큼 발급받으면 비용과 시간을 아낄 수 있습니다.

## 4. 회사·학교에 낼 서류

- □ 진단서 또는 소견서(치료 예정 기간 포함 여부 확인)
- □ 회사 취업규칙의 **병가·질병휴직** 조항 확인 — 법정 의무 병가는 없고 회사 규정에 따름(공무원·교원은 별도 규정)
- □ 상병수당: 일부 지역 시범사업 중 — 거주 지역·자격을 공단에 확인
- □ 개인 의료정보는 **필요한 만큼만** 알립니다. 병명 공개 범위는 내가 정합니다 (PART 4 「직장과 일상」 참고).

## 5. 진료 서류 모아두기(2차 소견·전원 대비)

| 서류                | 어디서         | 메모                              |
|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 병리보고서(조직검사 결과지)   | 진단 병원 의무기록팀 | 바이오마커 결과 포함 여부                  |
| 병리 슬라이드·파라핀 블록 대여 | 진단 병원 병리과   | 다른 병원 재판독·추가검사에 필요.<br>반납 기한 확인 |

| 서류          | 어디서                   | 메모                             |
|-------------|-----------------------|--------------------------------|
| 영상 CD + 판독지 | 진단 병원 영상의학과·<br>의무기록팀 | CT·MRI·PET 모두                  |
| 혈액검사 결과     | 의무기록팀                 | 최근 것                           |
| 진료의뢰서(소견서)  | 담당 의사                 | 상급종합병원 외래는 의뢰서가<br>있어야 건강보험 적용 |

**간암 참고:** 질병코드는 C22입니다. **영상으로만 진단된 간암**은 민간 암보험 약관의 "병리 진단" 조항 때문에 진단비 청구에 다툼이 생길 수 있습니다. 약관에 임상적 진단을 인정하는 조항이 있는지 확인하고, 진단서에 진단 근거 (영상 소견·종양표지자)를 적어 달라고 요청하세요. 산정특례 등록 기준도 원무과에 확인하세요.

# PART 6. 진료실 도구

## 진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 **3개만** 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다. 1. 영상 진단인가요, 조직 진단인가요? 2. 간기능(Child-Pugh·ALBI)은요? 3. 병기(BCLC·mUICC)는요? 4. 절제·이식·소작이 가능한가요? 5. TACE·방사선은 어떤가요? 6. 전신치료라면 무엇이고 정맥류 내시경이 필요한가요? 7. 간염 치료는 어떻게 계속하나요? 8. 간경변이 있다면 피해야 할 약은요? 9. 바로 연락해야 할 증상은요? 10. 임상시험이 있나요?

## 내 간암 한 장 요약

| 항목          | 내 기록                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 진단 방법       | 영상(LR-__) / 조직                                          |
| 크기·개수·혈관 침범 | _____                                                   |
| 간기능         | Child-Pugh _ · <b>ALBI</b> _                            |
| 병기          | BCLC _ · <b>mUICC</b> _                                 |
| 종양표지자       | AFP _ · <b>PIVKA-II</b> _                               |
| 간염          | B / C / 없음 · 약 _____                                    |
| 첫 치료        | 절제 / 이식 / 소작 / TACE / 방사선 / 전신치료                        |
| 산정특례        | <input type="checkbox"/> 신청 <input type="checkbox"/> 완료 |

**오늘 꼭 물을 3가지:** ① 제 간기능은? ② 어떤 치료가 가능한가요? ③ 간염 약은 계속 먹나요?

## 같은 진단, 다른 30일 (가상 사례)

감수단 환자 페르소나를 바탕으로 재구성한 가상의 이야기입니다.

**58세 진우 씨 — B형간염 보유자, 2cm 간암 고주파소작** "간염 약은 계속 먹나요?"가 첫 질문이었다. 답은 "네, 그것도 치료입니다." 소작은 짧은 입원으로 끝났고, 가족은 B형간염 검사를 받았다. "엄마에게서 왔을지도 모른다는 생각을 내려놓고, 아이들 접종을 챙기기로 했어요."

**66세 옥순 씨 — 간경변, TACE 예정** 시술 후 열이 나자 신호등 표를 봤다. "수일 내 가라앉는 미열"이었고, 사흘 뒤 내렸다. 남편은 간성뇌증 관찰 카드를 썼다. "무엇이 괜찮고 무엇이 위험한지 알면, 밤이 덜 무서워요."

**73세 상훈 씨 — 진행성, 면역치료 권유** 간기능이 나쁘는데 치료가 되냐고 물었다. Child-Pugh A라서 전신치료 대상이었고, 시작 전 내시경으로 정맥류를 치료했다. "제 간이 아직 힘이 있다는 걸 숫자로 들으니 용기가 났습니다."

## 용어사전

| 용어                | 쉬운 뜻           |
|-------------------|----------------|
| 간세포암종             | 가장 흔한 원발성 간암   |
| LI-RADS           | 간암 영상 진단 범주    |
| Child-Pugh / ALBI | 간기능 평가         |
| BCLC / mUICC      | 간암 병기 체계       |
| 고주파·극초단파 소작       | 바늘로 종양을 태우는 치료 |

| 용어           | 쉬운 뜻                  |
|--------------|-----------------------|
| TACE         | 간동맥으로 항암제·색전물질을 넣는 시술 |
| TARE         | 방사성 미세구를 넣는 시술        |
| 색전후증후군       | TACE 후 열·통증·메스꺼움      |
| 정맥류          | 간경변으로 부픈 식도·위 혈관      |
| 간성뇌증         | 간기능 저하로 생기는 의식 변화     |
| AFP·PIVKA-II | 간암 종양표지자              |
| 생체간이식        | 살아 있는 사람의 간 일부를 이식    |

## 자주 묻는 질문 12

**Q1. 조직검사를 안 했는데 정말 간암이 맞나요?** 간경변·간염 고위험군에서 CT·MRI의 전형적 소견(LR-5)은 국제·국내 지침에서 진단 기준으로 인정됩니다. 소견이 애매하면 조직검사를 합니다.

**Q2. B형간염 약은 간암 치료 중에도 먹나요?** 네. 항바이러스제는 간암 치료의 일부이며, 임의로 끊으면 간염이 악화될 수 있습니다.

**Q3. 고주파 소작과 수술 중 어느 것이 나은가요?** 작은 종양에서는 비슷한 결과를 보이는 경우가 많고, 위치·간기능·종양 개수에 따라 선택합니다.

**Q4. TACE는 몇 번이나 받을 수 있나요?** 반응과 간기능에 따라 반복합니다. 다만 반복할수록 간동맥이 손상되어 시술이 어려워질 수 있어, 반응이 없거나 간기능이 떨어지면 다른 치료로 바꿉니다. 국내 지침에서는 6개월 안에 두 번 이상 TACE를 해도 반응이 없거나, 새 혈관 침범·간 밖 전이가 생기면 '불응'으로 보고 전신치료나 방사선으로 바꾸는 것을 검토합니다. 시술할 때마다 일부에서 간기능 등급이 나빠질 수 있으니 바꿀 시점을 미리 물어 두세요.

**Q5. 간이식은 누구나 받을 수 있나요?** 종양 크기·개수·혈관 침범 기준과 간기능, 공여자 조건을 봅니다. 국내는 생체간이식 비중이 큼니다. 2024년 국내 간이식의 약 4분의 3이 생체간이식이었습니다. 또 TACE·방사선 등으로 종양을 줄인 뒤 이식을 검토하는 경우도 있으니 이식 가능성을 일찍 물어보세요.

**Q6. 술을 조금만 마셔도 되나요?** 간암·간경변이 있다면 금주가 원칙입니다. 끊기 어렵다면 금주 지원을 요청하세요.

**Q7. 간에 좋다는 즙·한약을 먹어도 되나요?** 간 손상이나 약물 상호작용 위험이 있어 상의 없이 먹지 않는 것이 좋습니다.

**Q8. 가족에게 B형간염이 옮았을까 걱정돼요.** 가족 검사와 예방접종으로 확인·예방할 수 있습니다. 누구 탓인지 따지기보다 검사와 접종에 집중하세요. 만 40세 이상으로 간경변이나 B·C형 간염이 있는 가족은 국가 간암 검진(6개월마다 간 초음파 + 혈액검사) 대상입니다.

**Q9. AFP가 정상인데 간암일 수 있나요?** 네. AFP가 오르지 않는 간암도 많습니다. PIVKA-II와 영상을 함께 봅니다.

**Q10. 면역치료를 받으려면 왜 내시경을 해야 하나요?** 혈관신생억제제가 포함된 요법은 정맥류 출혈 위험이 있어, 시작 전에 정맥류를 확인·치료합니다.

**Q11. 배에 물(복수)이 차면 어떻게 하나요?** 저염식과 이뇨제, 필요하면 복수 천자를 합니다. 열·복통이 함께 있으면 바로 연락하세요.

**Q12. 치료가 끝나도 왜 계속 검사를 하나요?** 간경변이 있는 간에서는 새 간암이 생길 수 있어 평생 정기 추적이 중요합니다.

## 진료실 대화법: 15분 진료를 30분처럼

**30초 요약:** 질문은 3개로 줄여 가져가고, 보호자가 적고, 마지막에 "제가 이해한 것이 맞는지 말해 볼게요"로 확인합니다.

## 진료 전날

- □ 질문 3개를 우선순위대로 적기(워크북 W2)
- □ 지난 진료 이후 바뀐 증상·약을 한 줄씩
- □ 검사 결과지·영상 CD·복용 약 목록 챙기기

## 진료실에서

1. 첫 문장으로 가장 중요한 것부터: "오늘 가장 궁금한 건 첫 치료가 무엇이고 언제 시작하는지예요."
2. 어려운 말이 나오면: "그 말을 쉽게 다시 설명해 주시겠어요?" "종이에 적어 주실 수 있나요?"
3. 선택지가 나오면: "선택지마다 장점과 단점, 그리고 선생님이라면 무엇을 고르실지 여쭙봐도 될까요?"
4. 끝나기 전: "제가 이해한 대로 말해 볼게요. ○○하고, 다음은 ○월 ○일 ○○ 검사죠?"
5. 연락처: "집에서 문제가 생기면 누구에게 연락하나요?"

## 녹음하고 싶다면

진료 내용을 기억하기 위해 녹음하고 싶을 때는 **먼저 의료진에게 양해를 구하세요.**  
허락이 어려우면 보호자 기록으로 대신합니다.

## 다학제 진료

여러 과(수술·종양내과·방사선종양학과·영상의학과·병리과 등)가 한자리에서 치료를 상의하는 진료입니다. 치료 선택지가 여럿이거나 순서가 중요한 경우 "다학제 진료를 받을 수 있나요?"라고 물어보세요.

## 검사 준비 카드

| 검사           | 준비                                                   | 알려야 할 것                                        | 소요(대략)               |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| CT(조영)       | 몇 시간 금식(병원 지시), 물 충분히(제한 없을 때)                       | <b>조영제 알레르기, 신장 기능 저하, 당뇨약 (메트포르민), 임신 가능성</b> | 촬영은 10~20분           |
| MRI          | 금속 제거, 일부는 금식                                        | <b>심박동기·인공와우·몸속 금속, 폐소공포증(진정 상담), 신장 기능</b>    | 30~60분               |
| PET/CT       | (FDG PET) 4~6시간 금식, 전날 격한 운동 피하기 · 다른 종류의 PET은 병원 안내 | <b>당뇨(혈당 조절법 미리 확인), 임신·수유</b>                 | 주사 후 대기 포함 2~3시간     |
| 조직검사<br>(바늘) | 금식 여부 확인                                             | <b>혈액을 묽게 하는 약(중단 여부는 의료진 지시), 알레르기</b>        | 시술 후 관찰 수시간          |
| 내시경          | 금식, 대장은 장 정결제                                        | 혈액을 묽게 하는 약, 당뇨약                               | 진정 시 보호자 동행·당일 운전 금지 |
| 뼈스캔          | 주사 후 물 많이 마시기                                        | 임신·수유                                          | 주사 후 2~4시간 대기        |

검사 결과는 "검사를 한 날"이 아니라 **"결과 설명을 듣는 날"**을 미리 예약해 두면 기다리는 불안이 줄어듭니다.

# 워크북

이 장은 오려 쓰거나 복사해 쓰도록 만들었습니다. 진료실에는 이 페이지만 들고 가도 됩니다.

## W1. 비상 연락처 카드 (휴대폰 사진으로도 저장)

| 항목                         | 기록          |
|----------------------------|-------------|
| 담당 교수 / 진료과                |             |
| 평일 진료실·외래 간호사실 ☎           |             |
| 야간·휴일 연락처 ☎                |             |
| 가까운 응급실(치료 병원 우선)          |             |
| 항암·방사선 치료실 ☎               |             |
| 보호자 1 / 보호자 2 ☎            |             |
| 국가암지식정보센터 암정보 상담(평일 9~18시) | ☎ 1577-8899 |
| 암생존자통합지지센터(지역암센터)          | ☎ 1577-9740 |
| 응급 119 · 정신건강 위기 109       |             |

## W2. 진료 기록지 (진료마다 1장)

| 항목            | 기록        |
|---------------|-----------|
| 날짜 / 진료과 / 의사 |           |
| 오늘 들은 진단·병기   | ✓ / ⌚ / ? |
| 오늘 결정된 것      |           |

| 항목           | 기록 |
|--------------|----|
| 다음 검사·날짜     |    |
| 다음 진료 날짜     |    |
| 새로 받은 약      |    |
| 꼭 지켜야 할 주의사항 |    |
| 다음에 물어볼 것    |    |

### W3. 7일 증상 일지

| 날<br>짜 | 체온<br>(최고) | 통증<br>0~10 | 식사(평소의<br>%) | 배변·<br>배뇨 | 잠 | 기분<br>0~10 | 메모·연락<br>여부 |
|--------|------------|------------|--------------|-----------|---|------------|-------------|
|        |            |            |              |           |   |            |             |
|        |            |            |              |           |   |            |             |
|        |            |            |              |           |   |            |             |
|        |            |            |              |           |   |            |             |
|        |            |            |              |           |   |            |             |
|        |            |            |              |           |   |            |             |

### W4. 복용 약·보충제 목록 (모든 진료에 지참)

| 이름 | 용량·횟수 | 왜 먹나 | 처방한 곳 | 의료진에 알림                  |
|----|-------|------|-------|--------------------------|
|    |       |      |       | <input type="checkbox"/> |
|    |       |      |       | <input type="checkbox"/> |
|    |       |      |       | <input type="checkbox"/> |
|    |       |      |       | <input type="checkbox"/> |

혈액을 묽게 하는 약(항응고제·항혈소판제), 당뇨약, 한약·건강기능식품은  
수술·시술·항암 전에 특히 중요합니다.

W5. 30일 체크 달력

| 주  | 날짜        | 한 일(✔) / 남은 일(⌚) |
|----|-----------|------------------|
| 1주 | Day 0-7   |                  |
| 2주 | Day 8-14  |                  |
| 3주 | Day 15-21 |                  |
| 4주 | Day 22-30 |                  |

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Hepatocellular Carcinoma, Version 2.2026. NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 대한간암학회·국립암센터 간세포암종 진료 가이드라인(최신판 확인), 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 간암 정보, 국민건강보험공단 산정특례 안내
- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 실지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- **참고문헌:** 보건복지부·국립암센터 국가암지식정보센터, 간암 정보(확인일 2026.10.04). 사실 확인용 참고문헌이며, 국가암지식정보센터의 저작물을 수록하지 않았습니다. 독자 안내: 공식 암 정보와 무료 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899.
- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.

- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.
- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
- 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.

---

**ApuDa | 아프지만, 다행이다.** · <https://apuda.app/>